Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 2 · Oktober 2026
S. 27–30 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

PRAXIS UND LEHRE

Logotherapeutisch orientierte Beratung bei Burnout und Sinnkrisen

Grundzüge, Vorgehen und Grenzen – mit einer konstruierten Lehrvignette

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer und Samuel R. Ashford
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Burnout wird in der Fachliteratur als Syndrom aus emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation bzw. Zynismus und reduziertem Leistungserleben beschrieben und in der ICD-11 als berufsbezogenes Phänomen, nicht als medizinische Erkrankung, klassifiziert. Neben arbeitsorganisatorischen Bedingungen wurde früh auf eine existenzielle Dimension hingewiesen: Burnout kann als Folge enttäuschter Sinnerwartungen an die eigene Arbeit verstanden werden. Der vorliegende Beitrag aus Praxis und Lehre entwickelt Grundzüge einer logotherapeutisch orientierten Beratung bei Burnout und Sinnkrisen. Nach einer begrifflichen Einordnung werden zentrale logotherapeutische Konzepte für die Beratung erschlossen, darunter das existenzielle Vakuum, die Unterscheidung zwischen Sinn und Erfolg, die drei Wertkategorien sowie die Dereflexion. Das methodische Vorgehen wird in vier Phasen dargestellt: Klärung und Abgrenzung, Entlastung und Stabilisierung, Sinn- und Werteexploration im sokratischen Dialog sowie Umsetzung und Transfer. Zur Veranschaulichung dient eine ausdrücklich konstruierte Lehrvignette, die keinen realen Beratungsfall wiedergibt. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Abgrenzung von Beratung und Psychotherapie, insbesondere der Notwendigkeit, depressive Störungen und andere behandlungsbedürftige Zustände zu erkennen und gegebenenfalls weiterzuverweisen, sowie der Gefahr, strukturelle Belastungen zu individualisieren.

Schlüsselwörter: Burnout · Sinnkrise · Logotherapeutische Beratung · Sokratischer Dialog · Beratungspsychologie

ABSTRACT

In the literature, burnout is described as a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization or cynicism, and reduced personal accomplishment, and it is classified in ICD-11 as an occupational phenomenon rather than a medical condition. Beyond organizational working conditions, an existential dimension was pointed out early on: burnout can be understood as a consequence of disappointed expectations of meaning in one's work. This contribution on practice and teaching outlines principles of logotherapeutically informed counseling for burnout and crises of meaning. Following a conceptual clarification, central logotherapeutic concepts are made accessible for counseling, including the existential vacuum, the distinction between meaning and success, the three categories of values, and dereflection. The methodological approach is presented in four phases: clarification and differential assessment, relief and stabilization, exploration of meaning and values in Socratic dialogue, and implementation and transfer. An explicitly constructed teaching vignette, which does not represent any real counseling case, serves as an illustration. Particular attention is paid to the boundary between counseling and psychotherapy, especially the need to recognize depressive disorders and other conditions requiring treatment and to refer clients where appropriate, as well as to the risk of individualizing structural stressors.

Keywords: burnout · crisis of meaning · logotherapeutic counseling · Socratic dialogue · counseling psychology

1 Einleitung und begriffliche Einordnung

Der Begriff Burnout hat seit den 1970er-Jahren eine erhebliche Verbreitung in Fachdiskussion und Öffentlichkeit erfahren. Maslach und Jackson (1981) haben mit dem Maslach Burnout Inventory ein Messinstrument vorgelegt, das Burnout über die Dimensionen emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und reduziertes Leistungserleben erfasst. In einer späteren Übersicht betonten Maslach et al. (2001) die Bedeutung des Passungsverhältnisses zwischen Person und Arbeitsumgebung, etwa hinsichtlich Arbeitsbelastung, Kontrolle, Anerkennung, Gemeinschaft, Fairness und Werten. Die Weltgesundheitsorganisation führt Burnout in der

ICD-11 als berufsbezogenes Phänomen im Kapitel der Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und ausdrücklich nicht als medizinische Erkrankung (World Health Organization, 2019).

Die Abgrenzung von Burnout gegenüber depressiven Störungen ist in der Forschung umstritten und für die Praxis von großer Bedeutung (Schaufeli & Enzmann, 1998). Der vorliegende Beitrag versteht Beratung daher ausdrücklich nicht als Behandlung psychischer Störungen. Er richtet sich an Fachpersonen in Beratungskontexten und beschreibt, wie logotherapeutische Konzepte bei berufsbezogener Erschöpfung und Sinnkrisen genutzt werden können – im Bewusstsein der Grenzen dieses Rahmens.

2 Die existenzielle Dimension des Burnouts

Pines (1993) hat Burnout aus einer existenziellen Perspektive gedeutet: Menschen, die in ihrer Arbeit eine wesentliche Quelle von Sinn suchen, seien besonders gefährdet, wenn sie erleben, dass ihr Einsatz nicht die erhoffte Bedeutung entfaltet. Burnout erscheint in dieser Sicht weniger als Folge bloßer Überlastung denn als Folge enttäuschter Sinnerwartungen. Diese Deutung ist mit Frankls Konzept des existenziellen Vakuums verwandt, das ein Gefühl innerer Leere und Sinnlosigkeit beschreibt (Frankl, 1969).

Logotherapeutisch bedeutsam ist zudem Frankls Unterscheidung zwischen Sinn und Erfolg. Wer den Wert der eigenen Arbeit ausschließlich an messbaren Ergebnissen, Anerkennung oder Effizienz misst, macht sein Sinnerleben von Bedingungen abhängig, die häufig außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Die Existenzanalyse hat dies weiter differenziert und auf die Bedeutung innerer Zustimmung zum eigenen Tun hingewiesen (Längle, 2013). Ein Tun, das zwar erfolgreich, aber ohne innere Zustimmung vollzogen wird, kann nach diesem Verständnis auf Dauer erschöpfen.

Gleichwohl ist Vorsicht geboten: Eine existenzielle Deutung darf nicht dazu führen, strukturelle Ursachen wie Arbeitsverdichtung, mangelnde Ressourcen oder ungerechte Organisationsbedingungen zu individualisieren. Sinnzentrierte Beratung ersetzt keine Veränderung belastender Arbeitsbedingungen, sondern kann allenfalls die Person darin unterstützen, ihren Handlungsspielraum zu erkennen und zu nutzen.

3 Logotherapeutische Konzepte für die Beratung

Für die Beratung bei Burnout und Sinnkrisen sind mehrere logotherapeutische Konzepte besonders hilfreich. Frankls drei Wertkategorien (Frankl, 1946) eröffnen einen differenzierten Blick auf Sinnquellen: Schöpferische Werte verwirklichen sich in der Arbeit selbst, sind aber nicht auf sie beschränkt; Erlebniswerte in Beziehungen, Natur oder Kultur können eine Gegenbewegung zu einer einseitig auf Leistung ausgerichteten Lebensführung bilden; Einstellungswerte betreffen die Haltung gegenüber Belastungen, die sich nicht unmittelbar ändern lassen. Schnell (2020) hat zudem darauf hingewiesen, dass eine größere Vielfalt an Sinnquellen mit einem stabileren Sinnerleben einhergehen kann.

Ein weiteres Konzept ist die Dereflexion. Sie zielt darauf, eine übermäßige, sorgenvolle Selbstbeobachtung zu lösen, indem die Aufmerksamkeit auf sinnvolle Aufgaben und Beziehungen jenseits der eigenen Befindlichkeit gelenkt wird. Lukas (1998) hat die methodische Anwendung der Dereflexion und anderer logotherapeutischer Verfahren für Beratung und Therapie ausführlich beschrieben. Bei Erschöpfung ist Dereflexion allerdings behutsam einzusetzen: Sie darf nicht als Aufforderung missverstanden werden, Warnsignale des Körpers zu übergehen.

Hilfreich ist außerdem die Frage, ob Sinn ausschließlich aus der Arbeit bezogen wird oder ob weitere Lebensbereiche zum Sinnerleben beitragen. Menschen mit sehr hoher beruflicher Identifikation beziehen oft einen Großteil ihres Sinnerlebens aus der Arbeit. Gerät diese Quelle in die Krise, fehlt es an Alternativen. Beratung kann dazu beitragen, das Spektrum möglicher Sinnquellen wieder zu erweitern, ohne die Bedeutung der Arbeit abzuwerten.

4 Methodisches Vorgehen in vier Phasen

Die erste Phase dient der Klärung und Abgrenzung. Hier werden Anliegen, Belastungsfaktoren und Ressourcen erhoben. Zugleich ist sorgfältig zu prüfen, ob Hinweise auf eine depressive Störung, eine Suchtproblematik, Suizidalität oder körperliche Erkrankungen vorliegen, die eine ärztliche oder psychotherapeutische Abklärung erfordern. Beratung kann in diesen Fällen eine Behandlung nicht ersetzen und sollte auf eine angemessene Weiterverweisung hinwirken.

Die zweite Phase zielt auf Entlastung und Stabilisierung. Erholung, Schlaf, soziale Unterstützung und gegebenenfalls Gespräche mit Vorgesetzten oder betrieblichen Ansprechpersonen stehen im Vordergrund. Sinnfragen werden in dieser Phase eher aufgenommen als vertieft, da eine akut erschöpfte

Person häufig nicht über die Kraft für eine grundlegende Neuorientierung verfügt.

In der dritten Phase erfolgt die Sinn- und Werteexploration, vorzugsweise im sokratischen Dialog. Logotherapeutisch verstanden zielt dieser nicht darauf, der ratsuchenden Person Sinn zuzuschreiben, sondern ihr durch Fragen zu ermöglichen, eigene Werterfahrungen und Möglichkeiten zu entdecken. Hier bestehen Berührungspunkte zur geleiteten Entdeckung in der kognitiven Verhaltenstherapie, die ebenfalls mit systematischem Fragen arbeitet (Kazantzis et al., 2014; Overholser, 1993). Der Unterschied liegt im Gegenstand: Während der sokratische Dialog in der kognitiven Verhaltenstherapie vor allem der Prüfung von Überzeugungen dient, richtet er sich in der Logotherapie auf Werte, Verantwortung und Sinnmöglichkeiten.

Die vierte Phase dient der Umsetzung und dem Transfer. Gemeinsam werden konkrete Schritte entwickelt, die das Erkannte in den Alltag übertragen: eine veränderte Gewichtung von Lebensbereichen, die Klärung beruflicher Rollen, die Pflege vernachlässigter Erlebniswerte oder auch die Entscheidung für eine berufliche Neuorientierung.

Wichtig ist dabei, dass die Schritte realistisch bleiben und die Erschöpfung nicht durch neue Leistungsansprüche verstärken. Eine logotherapeutisch orientierte Beratung fragt nicht nur, was eine Person tun soll, sondern auch, was sie lassen darf und welche Haltung sie gegenüber dem einnehmen möchte, was sich vorerst nicht ändern lässt.

5 Konstruierte Lehrvignette

Hinweis: Die folgende Vignette ist eine für Lehrzwecke konstruierte Darstellung. Sie gibt keinen realen Beratungsfall wieder; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen sind nicht beabsichtigt.

Eine erfahrene Pflegefachkraft auf einer internistischen Station sucht eine Beratungsstelle auf, weil sie sich seit Monaten erschöpft, gereizt und innerlich leer fühlt. Sie berichtet, dass sie ihren Beruf früher als Berufung erlebt habe, inzwischen aber den Eindruck habe, „nur noch zu funktionieren“. In der ersten Phase klärt die Beraterin, ob Hinweise auf eine depressive Störung vorliegen, und empfiehlt eine hausärztliche Abklärung, die die Ratsuchende auch wahrnimmt. In der Stabilisierungsphase werden Entlastungsmöglichkeiten besprochen, darunter ein Gespräch mit der Stationsleitung über die Dienstplanung.

In der Explorationsphase fragt die Beraterin im sokratischen Stil, in welchen Momenten der Arbeit die Ratsuchende zuletzt den Eindruck hatte, dass ihr Tun wichtig war. Die Ratsuchende erinnert sich an ein Gespräch mit einem schwer kranken Patienten, für das sie sich trotz Zeitdruck einige Minuten genommen hatte. Im weiteren Dialog wird deutlich, dass für sie weniger die Menge erledigter Aufgaben als die Qualität der Begegnung bedeutsam ist und dass gerade diese unter den gegenwärtigen Bedingungen zu kurz kommt. In der Transferphase entwickelt sie konkrete Schritte, um solche Begegnungen bewusster zu gestalten, und beschließt zugleich, die strukturellen Belastungen im Team anzusprechen.

Für die Lehre verdeutlicht die Vignette drei Punkte: die Notwendigkeit sorgfältiger Abklärung zu Beginn, die Verbindung individueller Sinnexploration mit der Benennung struktureller Belastungen sowie die Funktion des sokratischen Dialogs als Methode des Entdeckens statt des Belehrens.

6 Grenzen und Schlussfolgerungen

Logotherapeutisch orientierte Beratung kann Menschen mit berufsbezogener Erschöpfung und Sinnkrisen einen differenzierten Rahmen bieten, um ihre Situation zu verstehen und Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Ihre Wirksamkeit im Kontext von Burnout ist jedoch bislang nicht in kontrollierten Studien belegt; die hier dargestellten Grundzüge sind daher als theoretisch begründete und praxisbezogene Orientierung, nicht als evidenzbasiertes Behandlungsprogramm zu verstehen. Für die Weiterbildung ergibt sich die Aufgabe, neben der Vermittlung logotherapeutischer Konzepte insbesondere die Kompetenzen zur Abgrenzung von behandlungsbedürftigen Zuständen und zur Reflexion organisationaler Rahmenbedingungen zu stärken.

Für die Lehre eignet sich das beschriebene Vorgehen insbesondere zur Einübung einer fragenden, nicht belehrenden Gesprächsführung. In Rollenspielen können Studierende erproben, wie sich Fragen nach Werterfahrungen formulieren lassen, ohne Antworten nahezulegen, und wie sich Hinweise auf behandlungsbedürftige Zustände im Gespräch erkennen lassen. Supervision und Selbstreflexion sind dabei unverzichtbar, weil die Arbeit an Sinnfragen eigene Wertvorstellungen der Beratenden berührt und die Gefahr besteht, diese unbemerkt zu übertragen.

Literatur

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Kazantzis, N., Fairburn, C. G., Padesky, C. A., Reinecke, M., & Teesson, M. (2014). Unresolved issues regarding the research and practice of cognitive behavior therapy: The case of guided discovery using Socratic questioning. Behaviour Change, 31(1), 1–17.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Lukas, E. (1998). Lehrbuch der Logotherapie: Menschenbild und Methoden. Profil.

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2(2), 99–113.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422.

Overholser, J. C. (1993). Elements of the Socratic method: I. Systematic questioning. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 30(1), 67–74.

Pines, A. M. (1993). Burnout: An existential perspective. In W. B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and research (pp. 33–51). Taylor & Francis.

Schaufeli, W. B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. Taylor & Francis.

Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns (2. Aufl.). Springer.

World Health Organization. (2019). International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th rev.). World Health Organization.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Whitcombe, E. M., Pazer, S., & Ashford, S. R. (2026). Logotherapeutically Oriented Counseling for Burnout and Crises of Meaning: Main Features, Procedure, and Limitations – With a Constructed Teaching Vignette. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 27–30.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.